

FARINGOAMIGDALITIS

Bibliográfica Hospital Perrupato – Dr. Navarro David – 2019
Libro Azul de Infectología Pediátrica – TIPS módulo 7

Etiología:

- Menores de 3 años: la mayoría son episodios virales.

Los agentes virales pueden sospecharse por el período estacional, los antecedentes en el grupo familiar o ámbito escolar, los hallazgos clínicos acompañantes y las situaciones epidémicas.

En un estudio argentino, la secuencia de la faringitis estreptocócica a esta edad resultó del 9,7% y fue mayor en los que concurrían a jardines.

- 3-18 años: 20.6% faringitis estreptocócica
- En prepúberes y adolescentes, en el curso de la primavera prevalecen los cuadros producidos por el virus de Epstein-Barr; asimismo, aumenta la incidencia de infecciones por *Mycoplasma pneumoniae* y *Chlamydia pneumoniae*.
- En los pacientes con inicio de actividad sexual o en menores con antecedentes de abuso sexual debe considerarse la posibilidad de faringoamigdalitis por *N. gonorrhoeae* y *T. pallidum*.

El *S. pyogenes* puede también provocar:

- Formas supurativas: impétigo, escarlatina, celulitis y neumonías más frecuentemente y también artritis y sepsis.
- Formas no supurativas: Fiebre reumática y glomerulonefritis.

Transmisión de EβHGA en faringitis: el contacto debe ser íntimo y con proyección directa de grandes gotas o secreciones respiratorias.

El período de mayor contagiosidad es durante el estadio agudo de la enfermedad.

Los portadores nasales son más transmisores que los fauciales, pero raramente la portación persiste por semanas o meses.

Datos clínicos que orientan diagnóstico de faringitis estreptocócica:

- Comienzo en forma brusca
- Fiebre (100%)
- Odinofagia leve o moderada (84%) y grave (9,1%)
- Faringitis eritematosa (70%) y con exudado (30%)
- Cefalea (65%)
- Dolor abdominal (27%)
- Adenopatías submaxilares o cervicales, en general anteriores, aumentadas de tamaño y dolorosas (62%)
- Asociación con exantema escarlatinoforme (34%)

Etiología viral (70-80% de los casos):

- Rinovirus (20%)
- Coronavirus (>5%)
- Adenovirus (5%)
- Herpes simplex 1 y 2 (4%)
- Parainfluenza 1 a 4 (2%)
- Influenza A y B (1%)
- Otros: Coxsackie, Epstein-Barr, Citomegalovirus y VIH (<1%).

Se halló coinfección de *S. pyogenes* y VEB en 5% de casos de mononucleosis infecciosa.

Diagnóstico diferencial de la escarlatina:

- Síndrome de Kawasaki
- Staphylococcus
- Toxidermias

Herpangina

Se caracteriza por lesiones papulovesiculares en el paladar blando, úvula, amígdalas y pilares anteriores, que son seguidas por ulceraciones dolorosas que desaparecen en algunos días.

Mononucleosis infecciosa

Se caracteriza veces por una faringitis congestiva o exudativa, con falsas membranas extendidas y compromiso prolongado del estado general, puede presentar en su inicio petequias y se acompaña de adenomegalias retroesternomastoideas y en ocasiones generalizadas, con esplenomegalia y erupción.

Difteria

En la Argentina es extremadamente rara en pacientes pediátricos gracias a los programas de vacunación. Presenta membrana grisácea y gruesa sobre la faringe, difíciles de remover y sangrantes al intentar hacerlo, acompaña de obstrucción de la vía aérea.

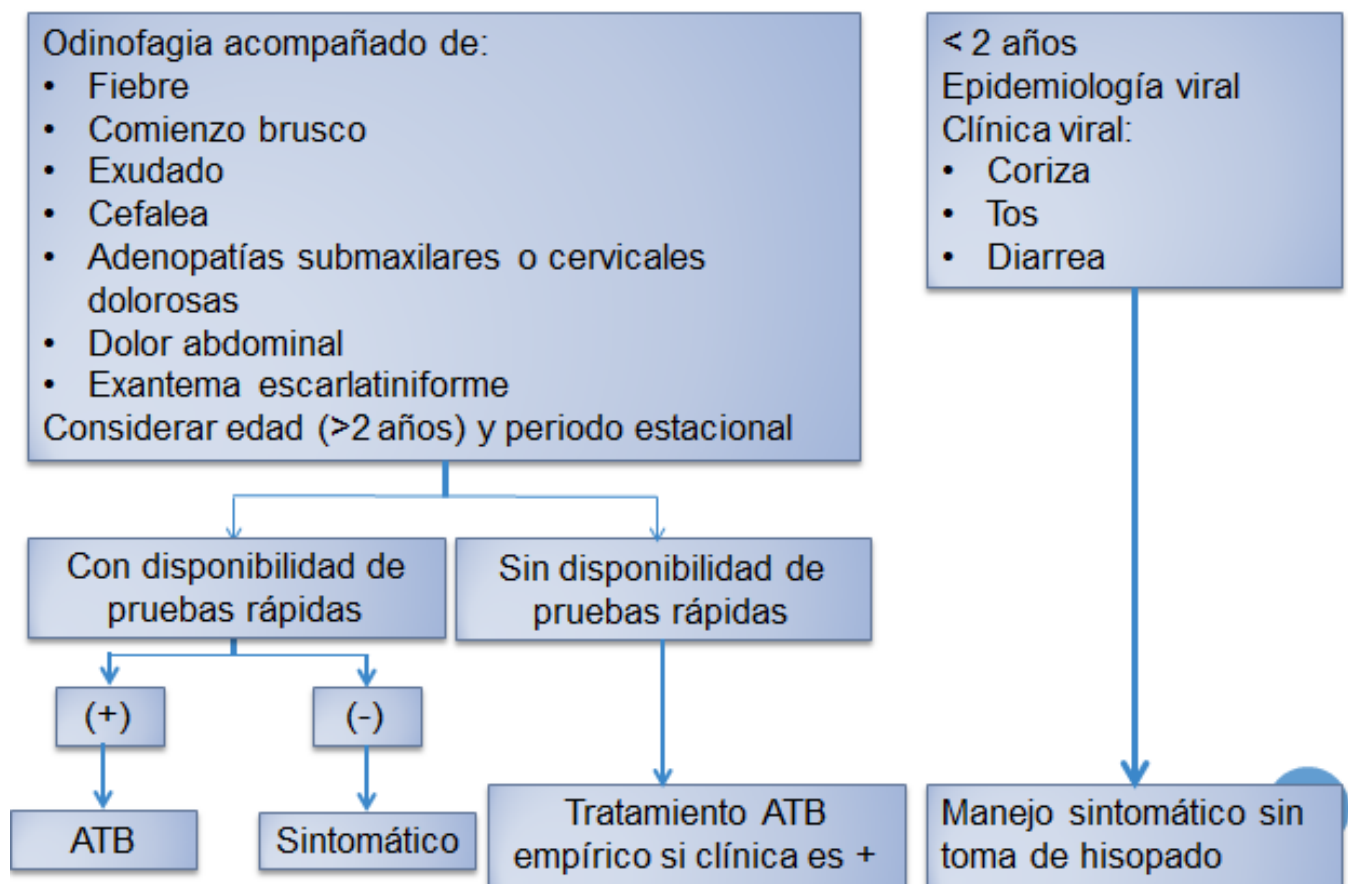
Métodos complementarios

Métodos rápidos

Se basan en la detección de antígenos polisacáridos de grupo mediante una reacción inmunológica (coaglutinación, látex, Elisa u OIA).

Cultivo de fauces

Algoritmo



Tratamiento

Faringitis viral: sintomático.

Faringitis por *S. pyogenes*:

- Penicilina V (fenoximetil-encilina) se utiliza en dosis de 50 000 U/kg/día, con dosis máximas de 1 500 000 U/ día, repartidas en dos dosis durante **10 días**.
- Amoxicilina a 50 mg/ kg/día (máximo 1.200 mg) durante **10 días**.
- Penicilina benzatínica:
 - 600 000 U en pacientes con menos de 27 kg
 - 1 200 000 U en los de más de 27 kg
 - Su uso debe quedar restringido a aquellos casos en los que no se pueden efectuar controles clínicos y se duda del cumplimiento del tratamiento.
 - No se la recomienda en menores de dos años.

Alérgicos a la penicilina: (la resistencia a los macrólidos es del 11,1%, en Mendoza)

- Eritromicina en dosis de 40 mg/kg/día, tres veces por día, durante 10 días
- Claritromicina 15 mg/kg/día cada 12 h por el mismo período
- Azitromicina a 10 mg/ kg/día, una vez al día durante 5 días.

Cefalosporinas de tercera generación y amoxicilina ac.Clavulánico no ofrece ventajas adicionales y puede favorecer el aumento de resistencia bacteriana

- Clindamicina: para las complicaciones supurativas; se puede utilizar en dosis de 20-30 mg/kg/día, cada 6-8 h por vía oral o por vía endovenosa a 40 mg/kg/ día cada 8 h. Es también una alternativa para alérgicos a betalactámicos.

Formas recurrentes

3 o más episodios sintomáticos documentados bacteriológicamente en los últimos 6 meses.

Es aconsejable cultivar a los convivientes simultáneamente y tratar a todos los portadores con Penicilina durante 10 días, más Rifampicina 20mg/Kg/día en los últimos 4 días.

Con repetición del cultivo a las 4 semanas.

Indicación de amigdalectomía

- Obstrucción de la vía aérea superior cuando ésta persiste fuera de un cuadro infeccioso o alérgico
- Cor pulmonale
- Absceso periamigdalino
- **Amigdalitis recurrente:** siete episodios por EβHGA documentados en 1 año o cinco episodios documentados en dos años consecutivos o tres episodios documentados en tres años consecutivos: indicación relativa de amigdalectomía.
- Quienes retienen detritus y material putrefacto en la amígdala. Su manifestación clínica es dolor permanente con feo gusto en la boca y halitosis.

Tratamiento de los portadores de EβHGA

No está indicado en la mayoría de los casos, solo ante:

- Brotes de fiebre reumática o glomerulonefritis posestreptocócica
- Brotes intrafamiliares de faringoamigdalitis estreptocócica y antecedentes familiares de fiebre reumática
- Múltiples episodios en la familia a lo largo de semanas a pesar del tratamiento antibiótico adecuado.

El antibiótico de elección es la clindamicina a 20 mg/ kg/día cada 8 h por 10 días, hasta un máximo de 1,8 g. Otros tratamientos incluyen la penicilina por 10 días con el agregado de Rifampicina a 20 mg/kg/día cada 12 h los últimos cuatro días. Las cefalosporinas son otra opción.